PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Comarca de Campos dos Goytacazes
3ª Vara Cível

AUTOS n. 0823840-22.2024.8.19.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: D. E. D. A.
RESPONSÁVEL: VERONICA DE SOUSA ESCOCARD

RÉU: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada por DAVI ESCOCARD DO AMARAL, representado por seu genitor VERÔNICA DE SOUSA ESCOCARD**,** em face de UNIMED FERJ, todos qualificados nos autos, objetivando o fornecimento de medicamento em favor do autor.

Na exordial, em breve síntese, consta que o autor se encontra diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84) e Deficiência Intelectual (CID 11: 6A02.3) – grau severo, nível III de suporte.

Sustenta o autor que, após ser verificada pela equipe médica a ineficiência de diversos tratamentos convencionais, foi-lhe receitado medicamento à base de Cannabis medicinal, na tentativa de buscar solução para proporcionar melhoria na qualidade de vida do menor.

O plano de saúde se negou a fornecer o medicamento.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que se determine que a ré custeie o medicamento, além de reparação por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Justiça gratuita deferida no index 181442115 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4871806&ca=c6ab211a9c49af9a19163ea8f3aa387922d3bd348139fec121a091d297fbf7066

Parecer do MP no index 198949190 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4871806&ca=c6ab211a9c49af9a19163ea8f3aa387922d3bd348139fec121a091d297fbf70661dc6c1990 opinado contrariamente à concessão da tutela antecipada.

A decisão de index 199008340 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4871806&ca=c6ab211a9c49af9a19163ea8f3aa387922d3bd348139fec121a091d297fbf7066 indeferiu a tutela provisória, bem como decreto a revelia do réu.

No index 110292399, decisão invertendo o ônus da prova.

As partes não requereram provas.

Parecer final do MP no index 216932074 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4871806&ca=c6ab211a9c49af9a19163ea8f3aa387922d3bd348139fec121a091d297fbf70661dc6c199C opinando pela improcedência do pedido.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir (art. 93, IX da CRFB e 489, §§1º e 2º, do CPC).

Tendo em vista que as partes não pugnaram pela produção probatória e que o réu é revel, promovo o julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, I e II, do Código de Processo Civil.

Trata-se de demanda que visa à condenação do réu na prestação da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos em razão de ser a parte autora portadora de Transtorno de Espectro Autista em grau avançado.

A relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes constitui relação de consumo, visto que estão presentes os elementos subjetivos e o elemento objetivo de tal relação (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, e produto/serviço – § 1º/§ 2º do artigo 3º da citada lei). Aplicam-se à espécie, portanto, as regras e princípios do microssistema jurídico do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ, inclusive, pacificou entendimento, por meio da edição da súmula 608, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde. Veja-se:

> ***SÚMULA 608 STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.***

Em que pese a decretação de revelia, persiste a controvérsia na obrigatoriedade ou não de o plano de saúde em arcar com os custos do medicamento à base de canabidiol.

Convém ressaltar que, em se tratando de contrato sinalagmático, constitui conduta abusiva de qualquer das partes a tentativa de eximir-se de suas obrigações básicas, afetando a própria a função social do contrato e colocando a parte contrária em situação vulnerável (artigos 187 c/c 422, ambos do Código Civil e artigo 51, IV, do CDC).

A adesão ao sistema de medicina conveniada, com o pagamento de prêmios para que as prestadoras reembolsem médicos, hospitais credenciados e procedimentos, demonstra a necessidade de diluição das despesas relativas ao custo da medicina particular no curso do tempo. A negativa de autorização de tratamento para doença coberta pelo plano coloca em risco o próprio objeto do contrato, ou seja, a busca da preservação da saúde e da vida, quando cientificamente possível. Contudo, a questão posta sob análise diz respeito não a autorização para tratamento de doença, mas a fornecimento de medicamento para combate à doença coberta pelo plano.

É reconhecido às operadoras a possibilidade de limitar doenças cobertas pelos contratos que oferecem. Entretanto, não se lhes é facultado glosar cobertura de procedimentos e medicações, especialmente quando indicados de forma fundamentada por médicos para tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado.

Nesse sentido, o verbete sumular nº 340 deste TJRJ:

> ***"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano."***

Em que pese a revelia, devem ser traçados algumas observações.

Primeiramente, o Tema 990 do STJ dispõe que "***As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA***."

Com efeito, tem-se que, no caso dos autos, o medicamento está devidamente registrado na ANVISA, sendo que o fato de não estar incluído no rol da ANS não afasta a possibilidade de sua prescrição pelo médico assistente, notadamente porque o referido rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde, conforme consta do § 12 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454, de 2022.

O medicamento prescrito ao autor está previsto no Anexo da Nota Técnica nº 37/2021, que apresenta a lista de produtos derivados de Cannabis que poderão ser importados por pessoa física para uso próprio, mediante prescrição médica, conforme art. 5º da RDC n° 335/2020.

Em segundo lugar, o plano de saúde tem responsabilidade de fornecer os medicamentos necessários ao paciente quando em tratamento médico-ambulatorial e hospitalar.

Todavia, medicamentos de uso domiciliar devem ser adquiridos pelo próprio paciente, salvo exceções previstas na própria lei em seu art. 10, inciso VI, o qual prevê:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
> *(...)*
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*

As alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12, a que faz referência o artigo acima transcrito, aduzem o seguinte:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
> *(...)*
> *C) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
> *(...)*
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*

Do que se observa, busca o requerente a condenação da parte ré ao fornecimento de medicamento derivado da cannabis para fins de tratamento de autismo, ou seja, não se trata de hipótese prevista nos artigos acima transcritos.

Isso afasta o dever do plano de saúde de arcar com os custos e importar o medicamento prescrito pelo profissional médico.

Esse entendimento foi adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1883654/SP, conforme se observa da ementa abaixo colacionada:

> *RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DETRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARCOBERTURA LEGAL COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEPRECEDENTE DAPRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. administração em ambiente externo ao de unidade de saúde salvo os antineoplásicos orais correlacionados), a medicação assistida (home care) e) e os incluídos no rolrol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nºnº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI,*

da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nºnº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe -se a ambulatorial e aa hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porq uanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é ine rente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regra s legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.
(REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃOSALOMÃO, QUARTA TURMA, ju lgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021)

Também este Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já decidiu no mesmo sentido em decisão recente que abaixo colaciono, in verbis:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL, PARA TRATAMENTO DE ALZHEIMER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Autora que, portadora de Alzheimer, doença incurável e irreversivel, já se submeteu a outros tratamentos, sem sucesso, lhe tendo sido indicado por seu médico o uso de medicamento à base de canabidiol (NABIX). 2. Negativa, pelo plano de plano de saúde do qual é beneficiária, com fundamento na ausência de cobertura obrigatória prevista no rol da ANS; por ser a utilização do medicamento de uso experimental, já que não consta da bula sua utilização para a finalidade indicada, e ser o mesmo de uso domiciliar, não cabendo o fornecimento pela operadora. 3. Atendimento das premissas constantes do REsp 1721705/SP. 4. Edição, pela ANVISA, da Resolução RDC nº 335/2020 (atualmente consolidada pela RDC 660/22), definindo "os critérios e os procedimentos para a importação de produtos derivados de cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde", tendo a autora obtido, desta Agência, a devida autorização para importação, o que supera a ausência de registro e a prescrição fora das indicações constantes da bula. 5. Medicação que, contudo, é de uso domiciliar, sem indicação de administração em ambiente hospitalar, encontrando seu fornecimento, pelo plano, óbice no que dispõe o art. 10, IV, da Lei 9656/98. Nesse sentido, Parecer Técnico nº 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, da ANS, que trata da cobertura de medicamentos à base de cannabis sativa e canabidiol. 6. Sentença que está a merecer reforma integral, pois, ausente a obrigatoriedade no fornecimento, não há que se falar em qualquer violação capaz de trazer o apontado dano moral. 7. Recurso provido. (0206408-83.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 13/12/2022 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Repiso, aqui, que o que se busca é o fornecimento pelo plano de saúde de medicação para uso domiciliar e que, conquanto busque amenizar efeitos deletérios de doença grave e sem perspectiva de cura, não se classifica como tratamentos antineoplásicos, de modo que glosa o direito do autor de ter o medicamento fornecido pelo plano de saúde para uso domiciliar.

É cediço que as empresas de seguro saúde devem fornecer o tratamento para doenças cobertas pelo plano de saúde do consumidor. Porém, a discussão travada nesta demanda ultrapassa a questão de a doença cujo tratamento se busca ser ou não coberta pelo plano (isso não se discute), bem como se o tratamento está ou não previsto no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS. O

ponto nodal é única e exclusivamente a obrigatoriedade ou não de o plano de saúde ofertar o medicamento para uso domiciliar e esta questão está prevista claramente na Lei 9.656/1998, não havendo margem para interpretações ou discussões.

Do documento de index 154497126 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4871806&ca=c6ab211a9c49af9a19163ea8f3aa387922d3bd348139fec121a091d297fbf70661dc6c199C denota que o consumo do medicamente ocorrerá pela via oral, não havendo nenhuma indicação de que a ingestão deva ser supervisionada ou o medicamento deva ser ministrado em ambiente hospitalar.

Inexiste previsão legal para o fornecimento ou custeio de medicamentos e insumos para tratamento em ambiente domiciliar, salvo as exceções previstas legalmente, que dizem respeito a antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no Rol da ANS como de cobertura obrigatória no ambiente domiciliar, o que não é o caso dos autos.

O art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias.

Nesse sentido, há, inclusive, Parecer Técnico da ANS sob o Nº 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, que assim dispõe:

> *"Portanto, uma vez que o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias, os produtos de cannabis indicados para uso domiciliar não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Todavia, podem as operadoras, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, ofertar cobertura maior que a obrigatória. Por outro lado, em atenção ao art. 12, inciso II, letra "d", da Lei nº 9.656/1998, os produtos de cannabis regularizados, prescritos para pacientes internados, em conformidade com as indicações previstas em seu folheto informativo (bula), serão de cobertura obrigatória. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei n.º 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura aos referidos medicamentos somente será devida caso haja previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual."*

Não há, portanto, como acolher o pedido formulado pela parte autora.

Sobre o alegado dano moral, ressalto que este é definido doutrinariamente como lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil).

Para que restasse configurado o dano moral, além de existir lesão aos direitos da personalidade, deveria ser demonstrado nexo causal entre este e a conduta ilícita da parte ré.

Como restou comprovado, a operadora não cometeu qualquer falha, de modo que não há que se falar em dano moral e, consequentemente, em compensação.

Nesse mesmo sentido, trago à baila jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Autora ingressou em Juízo narrando que, em razão do diagnóstico de ansiedade generalizada, (CID 10 F41.1) e transtorno depressivo grave (CID 10 F32.2), foi-lhe prescrito tratamento com o medicamento Canabidiol 1 Pure FS (3000mg/30ml), uma vez que não obteve resposta terapêutica utilizando as medicações disponíveis no Brasil. Afirma que o tratamento não foi autorizado pela operadora do plano de saúde. Por sentença, a obrigação de fazer foi confirmada, bem como a Demandada foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Operadora do plano de saúde se insurge arguindo a inexistência de obrigatoriedade de fornecer o fármaco de que necessita a Autora, em razão da taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde. Na hipótese, incontroverso o fato de a Autora ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela Demandada, bem como a recusa do*

fornecimento do medicamento. Mas em que pese a comprovação de obtenção da autorização para a importação do medicamento junto à ANVISA, infere-se do laudo médico acostado aos autos que a medicação prescrita é de uso domiciliar, não existindo qualquer indicação de administração em ambiente hospitalar. Tratando-se de saúde suplementar, não há previsão legal para o fornecimento ou custeamento de medicamentos e insumos para tratamento no âmbito domiciliar, salvo as exceções previstas legalmente. Nesse sentido, inclusive, é o recente Parecer Técnico nº 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar que dispõe sobre a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos à base de cannabis sativa e canabidiol. Assim, a recusa da operadora de plano de saúde para fornecimento do fármaco prescrito à parte Autora é legítima, diante do seu uso domiciliar, o que torna incabível a condenação da Demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Reforma integral da sentença que se impõe, com a inversão dos ônus da sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO. (0321670-81.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE - Julgamento: 01/12/2022 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, ante a ausência de comprovação do direito reclamado é forçoso o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, o que faço na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora vencida ao pagamento de custas processuais. Condeno ainda a promovente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados do réu fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º do CPC. Fica, contudo, a cobrança suspensa, em razão da gratuidade de justiça já deferida à parte autora.

Registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.

Ficam as partes intimadas de que, após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, os autos serão baixados e remetidos à Central ou Núcleo de Arquivamento do 6º NUR, nos termos do artigo 207, § 1º, I, da CNCGJ.

Campos dos Goytacazes, 14 de agosto de 2025.

HELENICE RANGEL GONZAGA MARTINS
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: HELENICE RANGEL GONZAGA MARTINS
03/09/2025 14:12:25
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25090314122558400000206500755

IMPRIMIR GERAR PDF